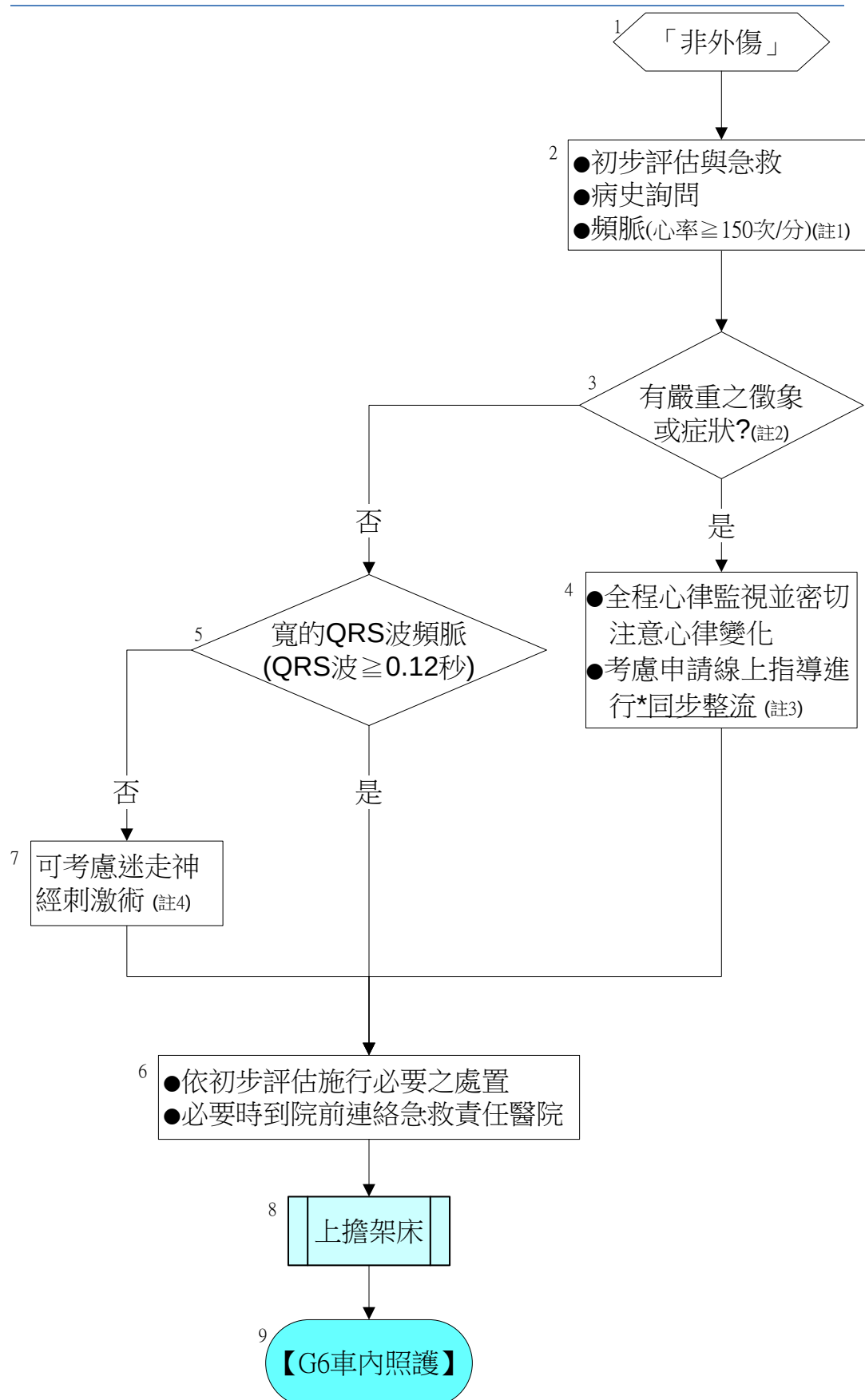


M9 **P**嚴重頻脈 (Tachycardia)

程 序



要 旨

- 一、本程序建議之處置僅限 EMTP 操作。EMT2請依通用程序（G）處理此類傷病人。
- 二、EMTP在初步評估時檢查脈搏若發現傷病人（嬰兒與新生兒除外）脈搏次數每分鐘 ≥ 150 時，即建議使用本程序。
- 三、醫學上定義脈搏每分鐘 ≥ 100 次為頻脈；此時傷病人可能有無力感、心悸感或昏厥感，但通常不須用到本程序建議之處置。與嚴重之徵象或症狀相關的頻脈或緩脈，往往是 ≥ 150 。

註 解

註1>

- 一、頻脈患應注意A-B-C，獲得相關病史及準備急救器材。
- 二、脈搏每分鐘 ≥ 100 次，定義為頻脈，依據AHA 2020年ACLS指引，每分鐘 ≥ 150 次之頻脈需予以積極監測與處置。

註2>

嚴重之徵象或症狀是指--急性心臟衰竭、休克徵候、急性意識改變、低血壓、缺血性胸痛共五大徵候。

註3>

- 一、時機：病人無意識並出現註2所示之徵候。
- 二、同步整律時應同時準備急救器材。
- 三、*同步整律之起始能量建議（雙向波）：

整律能量（J）	窄QRS	寬QRS
規則	100(50-100)	100
不規則	200(120-200)	去顫電擊（120以上）

若初次同步整律失敗，後續同步整律以漸增能量為之（increase in stepwise fasion）；若同步整律已使用200J，仍持續整律時以200J為之。

- 四、意識清楚的病人宜在止痛後操作。

註4>

施作迷走神經刺激術，病人須為平躺或半坐臥，可考慮以下三種方式：



請病人捏鼻鼓氣或咳嗽。

可考慮使用modified Valsalva maneuver。

- (一) 先跟病人解釋步驟（吹氣 15 秒後會讓病人躺下並且抬腳）。
- (二) 請病人張口含住 10ml 針筒出口處用力吹氣 15 秒，力量盡量能夠推動針筒活塞。
- (三) 救護人員同步倒數 15 秒（15, 14, 13, 12.....5, 4, 3, 2, 1, 放倒）。
- (四) 擔架床椅背放倒的同時，救護人員需要同時將病人雙腳抬高 45 度，維持 15 秒。
- (五) 救護人員同步倒數 15 秒（15, 14, 13, 12.....5, 4, 3, 2, 1, 坐起）。
- (六) 病人回復原姿勢休息 30 秒，期間請以 3 導程、SpO₂或量測橈動脈評估心率。

禁忌症：收縮壓<90 mmHg、懷孕 28 周後之孕婦。



三、頸動脈竇按摩術:僅限於小於50歲的病人，操作前聽診頸動脈雜音，有雜音不能頸動脈按摩。

- (一) 按摩點選在頸總動脈分叉部(相當於胸鎖乳突肌上 1/3)。
- (二) 每次按摩時間不超過 5 秒，(可嘗試先試左側)，左右兩側按摩的時間間隔應大於 15 秒，且避免同時作雙側按摩。
- (三) 必須注意，伴有頸動脈粥樣硬化、頸動脈炎、頸動脈周圍淋巴結腫大的人需慎重使用，以防止發生腦血管意外。